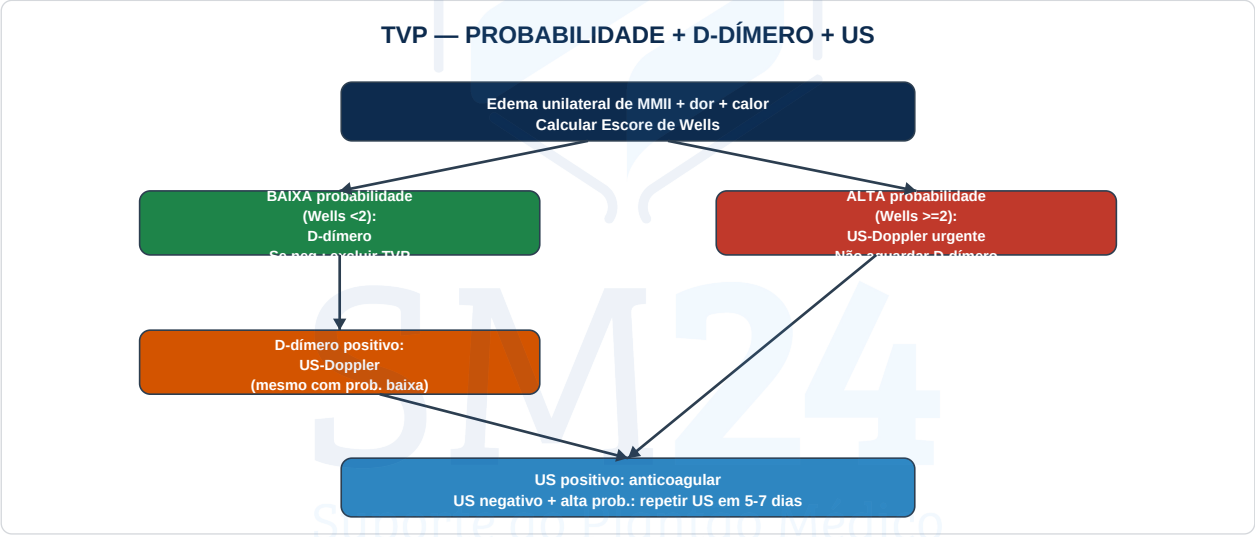


# TVP — WELLS + US + ANTICOAGULAR

## ESCORE DE WELLS — PROBABILIDADE PRÉ-TESTE

| Critério                                             | Pontuação | Interpretação                                         |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| Câncer ativo (tratamento em 6 meses ou paliativo)    | +1        | Total >=3: alta probabilidade (75%)                   |
| Paralisia ou imobilização recente de membro inferior | +1        |                                                       |
| Acamado >=3 dias OU grande cirurgia em 12 semanas    | +1        |                                                       |
| Dor localizada no trajeto venoso profundo            | +1        | D-dímero: útil apenas se probabilidade baixa/moderada |
| Edema em todo o membro inferior                      | +1        | D-dímero negativo + baixa prob.: exclui TVP           |
| Edema com cacifo, maior que o lado contralateral     | +1        | US: exame diagnóstico padrão (compressão venosa)      |
| Circulação colateral superficial (não variz)         | +1        | Se US negativo + alta prob.: repetir US em 1 semana   |
| Diagnóstico alternativo tão ou mais provável         | -2        |                                                       |

## ALGORITMO DIAGNÓSTICO TVP



## ANTICOAGULAÇÃO NA TVP

| Cenário                                   | Droga de escolha                                       | Duração                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TVP proximal não provocada                | DOAC (rivaroxabana 15 mg 12/12h x 21d, depois 20 mg/d) | 3-6 meses; avaliar tratamento indefinido      |
| TVP proximal provocada (cirurgia, viagem) | DOAC ou varfarina                                      | 3 meses — fator de risco removido             |
| TVP distal isolada sintomática            | DOAC ou HBPM                                           | 3 meses; observação possível se assintomática |
| TVP + câncer                              | HBPM (dalteparina) OU DOAC (apixabana, rivaroxabana)   | Indefinido enquanto câncer ativo              |
| TVP na gestação                           | HBPM (enoxaparina) — não DOAC                          | Até pelo menos 6 semanas pós-parto            |
| Síndrome antifosfolípide                  | Varfarina INR 2-3 (DOACs: risco maior de recorrência)  | Indefinido                                    |

## TROMBOFLEBITE SÉPTICA — ATENÇÃO

### TVP + FEBRE + SINAIS INFLAMATÓRIOS = SÉPTICA

- Tromboflebite séptica: infecção bacteriana associada ao trombo venoso
- Causas: cateter IV, infecção pélvica, cirurgia, usuário de drogas IV
- Clínica: febre alta + cordão venoso inflamado e doloroso + calafrios + bacteremia
- Hemoculturas antes do ATB (S. aureus mais comum)
- ATB IV: oxacilina 2g 4/4h (ou vancomicina se MRSA suspeito)
- Anticoagulação: indicada em conjunto com ATB — sem benefício isolado sem ATB

## SÍNDROME PÓS-TROMBÓTICA E PROFILAXIA

### Síndrome Pós-Trombótica

- Ocorre em 20-50% dos pacientes após TVP proximal
- Clínica: dor, edema crônico, varizes secundárias, lipodermatoesclerose, úlcera
- Prevenção: anticoagulação adequada + meia elástica 30-40 mmHg por 2 anos
- Deambulação precoce: não está contraindicada na TVP — reduz risco de TEP? (não comprovado)
- Filtro de veia cava inferior: apenas se contraindicação absoluta à anticoagulação

### Profilaxia de TVP

- Cirurgia de alto risco (ortopédica, neoplásica): enoxaparina 40 mg SC/d + meia de compressão
- Imobilização prolongada: enoxaparina profilática se risco moderado-alto
- Deambulação precoce: principal medida não farmacológica
- Escore de Caprini: estratifica risco cirúrgico e orienta profilaxia
- Anticoagulação prolongada: pós-artroplastia total de quadril/jelho por 35 dias

## TVP EM MEMBRO SUPERIOR

### DIFERENÇAS E PARTICULARIDADES

- ☐ Causas: cateter venoso central (60%), esforço (Paget-Schroetter), tumor mediastinal, trombofilia
- ☐ Paget-Schroetter: jovem atleta (nadador, jogador de vôlei) com TVP subclávia ou axilar por esforço
- ☐ Risco de TEP: menor que MMII, mas real (~5%)
- ☐ Tratamento: anticoagulação igual ao MMII; fisioterapia se Paget-Schroetter
- ☐ Trombólise/trombectomia: considerar em Paget-Schroetter com sintomas graves
- ☐ Retirar cateter central se for a causa e possível — anticoagular por 3 meses

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 55 anos com edema unilateral em MMII, dor no trajeto venoso, cirurgia ortopédica há 2 semanas. Escore de Wells = 3. Qual é a conduta diagnóstica?

- A) D-dímero isolado — se negativo, excluir TVP
- B) US-Doppler urgente — não aguardar D-dímero em alta probabilidade
- C) TC de tórax para excluir TEP
- D) Alta com meia elástica e retorno em 1 semana
- E) Iniciar anticoagulação empírica sem nenhum exame

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Mulher de 32 anos, gestante de 20 semanas, com TVP proximal confirmada. Qual anticoagulante é o mais adequado?

- A) Rivaroxabana 20 mg/dia
- B) Varfarina INR 2-3
- C) Enoxaparina 1 mg/kg 12/12h subcutânea
- D) Apixabana 5 mg 12/12h
- E) Ácido acetilsalicílico 100 mg/dia

### QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é a limitação do D-dímero no diagnóstico de TVP?

- A) Baixa sensibilidade — muitos casos de TVP têm D-dímero normal
- B) Alta sensibilidade mas baixa especificidade — positivo em gravidez, pós-operatório, infecção, idosos
- C) Só detecta TVP de MMSS
- D) Inválido em pacientes anticoagulados
- E) Detecta apenas trombo recente (<24h)

### QUESTÃO 4

SES-MG / Adaptada

Paciente com TVP proximal e diagnóstico recente de carcinoma de pulmão. Qual é o anticoagulante de escolha?

- A) Varfarina INR 2-3
- B) Rivaroxabana 20 mg/dia por 3 meses e suspender
- C) HBPM (dalteparina) ou DOAC (apixabana/rivaroxabana) por tempo indefinido
- D) Ácido acetilsalicílico 300 mg/dia
- E) Heparina não fracionada IV por 5 dias e suspender

### QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Síndrome de Paget-Schroetter é descrita como TVP em:

- A) Veia femoral superficial em paciente imobilizado
- B) Veia poplítea em gestante
- C) Veia subclávia ou axilar por esforço em jovem atleta
- D) Seio venoso cerebral em usuário de anticoncepcional
- E) Veia cava inferior em paciente com trombofilia

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

Wells  $\geq 3$  = alta probabilidade de TVP. Conduta: US-Doppler imediato — D-dímero é útil apenas em baixa/moderada probabilidade (se negativo, exclui). Em alta probabilidade, D-dímero tem baixo valor preditivo negativo. US-Doppler com compressão venosa: padrão-ouro.

### QUESTÃO 2 → Resposta: C

TVP na gestação: HBPM (enoxaparina) é a única anticoagulante segura — não atravessa a placenta. DOACs (rivaroxabana, apixabana) são contraindicados na gestação. Varfarina é teratogênica no 1o trimestre. Dose terapêutica: enoxaparina 1 mg/kg 12/12h.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

D-dímero: alta sensibilidade (~97%), baixa especificidade. Positivo em muitas situações (gestação, pós-op, infecção, câncer, idoso, AVC). Valor: exclusão em baixa/moderada probabilidade — D-dímero NEGATIVO + baixa probabilidade = exclui TVP. Positivo não confirma.

### QUESTÃO 4 → Resposta: C

TVP + câncer: HBPM (dalteparina 200 UI/kg/d) ou DOAC (apixabana 10 mg 12/12h x 7d, depois 5 mg 12/12h) — indefinido enquanto câncer ativo. Varfarina tem interações com quimioterapia e INR instável. Risco de recorrência 3-5x maior que sem câncer.

### QUESTÃO 5 → Resposta: C

Paget-Schroetter: TVP de esforço em veia subclávia ou axilar — jovens atletas (nado, vôlei, musculação intensa) com compressão do desfiladeiro torácico (primeira costela + músculo subclávio). Tratamento: anticoagulação + fisioterapia; pode precisar de descompressão cirúrgica.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico